

시 정 · 권 고 요 구

1. 제 목 물리치료 인정비용 심사 미흡

2. 내 용

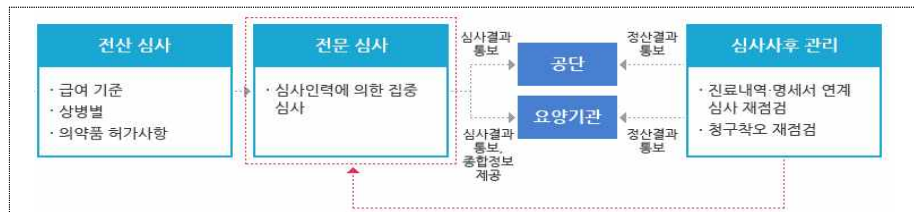
우리 원은 국민건강보험법 제63조에 따라 요양기관으로부터 청구된 요양급여비용이 요양급여의 기준 및 요양급여비용 산정기준에 따라 적합하게 산정되었는지를 확인하여 심사하고 있다.

요양급여비용 심사업무는 【그림 1】과 같이 전산심사와 전문심사, 사후관리 단계로 구분되며, 전산심사는 급여기준 중 정형화가 가능한 부분을 전산 프로그램화하여 심사조정 또는 심사직원이 참고할 수 있는 메시지를 제공하는 것이다.

전문심사는 청구된 명세서를 심사직원이 직접 심사하는 방법으로 일차적으로 심사직원에 의한 심사가 이루어지고, 전문의학적 판단이 필요한 경우 해당 분야 전문의사가 하는 심사위원 심사와 여러 전문가가 모여서 적정성 여부를 심사하는 심사위원회 심사 등으로 구성되어 있다.

사후관리는 요양급여비용 지급 후 수진자별, 진료기간별 또는 의료공급자간 연계 확인이 필요한 것에 대해 재점검하는 것이다.

【그림 1】 요양급여비용 심사 업무 처리절차



물리치료 인정비용 심사는 먼저 전산심사 과정을 통해 인정된 물리치료 청구횟수, 인정 가능 횟수를 산출하고 심사가 필요한 접수번호에 중점관리 사항으로 표시하여 전문 심사 시 참고하도록 하고 있다.

심사직원은 이를 참고하여 요양기관의 물리치료 인정 가능횟수와 청구횟수를 비교하여, 물리치료사(또는 한의사) 1인당 1일 실시 인원을 초과하는 경우 물리치료 인정비용 심사 조정을 하여야 한다.

또한 요양기관에서 퇴사일자 등 인력변경 현황을 지연하여 신고한 경우, 요양기관 현황관리 담당자는 인력 변경현황 처리 시 퇴사일자와 지연신고 일자 사이의 기 지급된 요양급여비용의 과다지급 여부를 확인하여야 한다.

이와 관련 물리치료사(또는 한의사) 1인당 1일 실시 인원은 과잉진료를 방지하고 의료서비스 질적 향상과 적정진료 유도를 위해 보건복지부 고시에 의거 월평균(또는 주평균) 1일 30명으로 정하고 있다.

☞ 참고자료: 【요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침】

물리치료사 1인당 1일 물리치료 실시 인원

(고시 제2010-31호, '10.6.1. 시행) 해당항목의 물리치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 해당 치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있는 요양기관(보건기관 포함)에서 재활 및 물리치료를 실시한 경우에 상근하는 물리치료사 1인당 물리치료 실시인원(물리치료 실시 총 청구건수를 의미함)은 월평균(또는 주평균) **1일 30명까지 인정**하며, 이 경우 의료급여 환자를 포함함. 다만, 상근물리치료사 1인 이상이 근무하는 기관에서 시간제, 격일제 근무자(주3일 이상 이면서 주20시간 이상 근무하는자)의 경우 0.5인으로 보아 월평균(또는 주평균) 1일 15명까지 인정함.

※ 월평균(주평균) 물리치료실시인원 = 1개월간(1주일간) 총 물리치료청구건수(물리치료 실시 연인원) ÷ 1개월간(1주일간) 물리치료사 근무일수

한의사 1인당 1일 온냉경락요법 실시 인원

(고시 제2021-289호, '21.12.1. 시행) 요양기관(보건기관 포함)의 침구실 등에서 한방물리요법을 실시한 경우에 상근하는 한의사 1인당 온냉경락요법 실시인원(온냉경락요법 실시 총 청구건수를 의미함)은 월평균(또는 주평균) **1일 30명까지 인정**하며, 이 경우 의료급여 환자를 포함함. 다만, 시간제, 격일제 근무자는 주3일 이상 이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 보아 월평균(또는 주평균) 1일 15명까지 인정함.

※ 월평균(주평균) 온냉경락요법 실시인원 = 1개월간(1주일간) 총 온냉경락요법 청구건수(온냉경락요법 실시 연인원) ÷ 1개월간(1주일간) 한의사 근무일수
 * '21.12. 이전에는 고시 제2011-10호(2011.2.1.시행)에 따라 한의사 1인당 온냉경락요법 실시인원(온냉경락요법 실시 총 청구건수를 의미함)은 월평균(또는 주평균) 1일 20명까지 인정함.

감사 대상기간('21년9월~'22년04월) 동안 피감부서의 물리치료 인정비율 심사 현황을 확인한 결과, 【표 1】과 같이 물리치료 인정비율 심사 누락이 피감부서에서 지속적·반복적으로 발생하고 있음을 확인하였다.

【표 1】 물리치료 인정비율 심사 누락 현황

(단위: 건, 개, 원)

연번	요양기호	요양기관명	부서	진료 년월	접수 번호	영세서 건수	물리치료 청구횟수	정산금액 (추정)
총 계						121,857	142,209	66,323,790
1	*****	AA한의원	○○	202111	*****	706	706	385,730
2	*****	BB한의원	○○	202203	*****	840	840	140,364
3	*****	BB한의원	○○	202203	*****	4	4	668
4	*****	CC의원	◎◎	202110	*****	1,337	1,335	540,094
5	*****	DD한의원	◎◎	202111	*****	644	644	123,917
6	*****	EE한의원	◎◎	202203	*****	822	822	113,677
7	*****	FF의원	◇◇	202109	*****	562	561	100,145
8	*****	GG한의원	◇◇	202201	*****	669	669	78,589
9	*****	HH한의원	◇◇	202111	*****	418	418	12,352
10	*****	II한방병원	□□	202112	*****	50	1,381	1,883,684
11	*****	II한방병원	□□	202112	*****	7	167	227,788
12	*****	KK한방병원	□□	202202	*****	162	162	226,638
13	*****	LL의원	△△	202110	*****	723	723	271,335
14	*****	MM의원	△△	202109	*****	655	655	196,648
15	*****	NN한의원	△△	202110	*****	932	932	126,842
16	*****	OO의원	♡♡	202203	*****	227	227	319,783
17	*****	OO의원	♡♡	202203	*****	153	153	114,280
18	*****	PP의원	♡♡	202204	*****	19	19	59,534
19	*****	QQ의원	♣♣	202201	*****	1,058	1,058	2,259,895
20	*****	QQ의원	♣♣	202202	*****	1,000	1,000	2,244,067
21	*****	RR의원	♣♣	202201	*****	679	667	401,163
22	*****	SS의원	♠♠	202111	*****	1,385	1,385	205,525
23	*****	TT의원	♠♠	202110	*****	381	381	132,707
24	*****	UU의원	♠♠	202112	*****	782	778	121,366
25	*****	VV의원	◁▷	202109	*****	672	669	50,620
26	*****	VV의원	◁▷	202109	*****	32	32	2,339
27	*****	WW의원	◁▷	202202	*****	1,005	1,004	274,742

(단위: 건, 개, 원)

연번	요양기호	요양기관명	부서	진료 년월	접수 번호	영세서 건수	물리치료 청구횟수	정산금액 (추정)
28	*****	XX한의원	▷▷	202204	*****	1,115	1,115	851,521
29	*****	YY한의원	▷▷	202201	*****	3,008	3,008	570,768
30	*****	ZZ한의원	▷▷	202110	*****	821	821	529,507

... (생략) ...

* 수감부서 제출자료 재구성
 ** ♠♠ 및 ◁▷부서 자율점검 조치 완료건 포함

이에 물리치료 인정비율 심사관련 현황을 분석한 결과 【표 2】와 같이 심사 누락과 적용기준 상이로 누락이 불분명한 경우로 나눌 수 있으며, 심사 누락 사유로는 단순 심사누락과 일반 전산 심사로 인한 심사직원 미확인이 가장 많았다.

합산심사 적용범위나 인정비율 소수점 차이, 조정금액이 소액인 경우 등 피감부서별 적용기준이나 방법이 상이하여 심사 누락이 모호한 경우도 있어, 이에 대한 기준 정립이 필요하다고 판단된다.

【표 2】 물리치료 인정비율 심사 누락·적용기준 상이 원인 분석

(단위: 건, %)

구분		전체		청구단위 누락		접수번호 단위 누락	
전체		189,509		45,152		144,357	
심사 누락	소계	121,857	(100.0)	37,065	(100.0)	84,792	(100.0)
	단순 심사누락	74,127	(60.8)	27,922	(75.3)	46,205	(54.5)
	일반 전산심사	28,556	(23.4)	2,254	(6.1)	26,302	(31.0)
	착오계산·입력	14,706	(12.1)	3,744	(10.1)	10,962	(12.9)
	물리치료사 지연신고	4,468	(3.7)	3,145	(8.5)	1,323	(1.6)
적용 기준 상이	소계	67,652	(100.0)	8,087	(100.0)	59,565	(100.0)
	비율 소수점 1%미만 차이	21,266	(31.4)	-	-	21,266	(35.7)
	주단위-월단위 합산	6,714	(9.9)	3,837	(47.4)	2,877	(4.8)
	건강보험-의료급여 합산	1,179	(1.7)	-	-	1,179	(2.0)
	정액청구기관의 외래 합산	231	(0.3)	231	(2.9)	-	-
	지연·추가 청구건 합산	30,215	(44.7)	4,019	(49.7)	26,196	(44.0)
	물리치료사 지연신고 합산	2,413	(3.6)	-	-	2,413	(4.1)
	조정금액 소액	5,603	(8.3)	-	-	5,603	(9.4)
	착오계산·입력	31	(0.05)	-	-	31	(0.1)

* 수감부서 제출자료 재구성

이에 요양급여비용 심사업무 처리 절차별 물리치료 인정비율 심사업무 전반을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점 및 개선 필요사항이 확인되었다.

가. 전산심사 업무

심사직원은 청구서 처리 화면에서 중점관리 “M”이 표시된 접수번호의 물리치료 청구현황 및 물리치료사·한의사의 근무현황 등을 확인·숙지하며 심사를 준비한다.

중점관리 구분자 “M”은 동일 진료년월의 누적한 물리치료 청구횟수가 월인정 가능횟수보다 크거나 인력신고 의사 중 비상근만 있는 경우 표시하고 있다.

참고자료: 【HIRA+ 화면심사 사용자 매뉴얼】

■ 중점관리 심사항목 구분자				
구분	중점관리 구분자	중점 표시 조건	인력 및 근무일수 참고치*	인정비율 화면
의과 물리치료	M	· 누적청구횟수>인정가능횟수 · 인력신고 의사 중 비상근만 있는 경우	· 인력신고 의사수 기준 · MT025(물리치료사 공휴일근무현황)	물리치료횟수청구 현황조회(JSE051)
한방 물리치료	M	· 누적청구횟수>인정가능횟수 · MT050 기재누락 및 오류	· MT050(한 의사토요 일·공휴일근무현황)	한방물리요법청구 현황조회(JSE053)

이에 일부 피감부서의 '22년1월~'22년6월(6개월)¹⁾동안 중점관리 “M”표시 청구현황을 분석한 결과, 중점관리 “M”표시 접수번호 1,763건 중에서 물리치료횟수 청구현황 화면 상 물리치료 인정비율이 100%로 물리치료 인정비율 심사 조정이 불필요한 경우가 1,582건으로 89.7% 수준으로 대다수를 차지한 것으로 보인다.

이와 관련, 피감부서에서 중점관리 “M”이 표시된 접수번호임에도 불구하고 물리치료 인정비율이 100%로 별도의 심사조정이 불필요한 경우가 많아 실효성이 부족하다는 의견을 제시하였다.

1) 중점관리 “M” 표시 청구 건 대비 물리치료 인정비율 현황에 대한 비율을 확인하기 위해 데이터 산출·분석 소요시간을 고려하여 산출함

【표 3】 중점관리 “M” 표시 청구현황

(단위: 건, 개, %)

구분	물리치료 청구		중점관리 “M” 표시				
	접수번호 수	청구횟수	접수번호 수	(비율)	청구횟수	(비율)	
전체	34,149	8,234,821	1,763	(100.0)	980,591	(100.0)	
물리치료 인정비율	100%	33,861	8,120,451	1,582	(89.7)	890,562	(90.8)
	100% 미만	288	114,370	181	(10.3)	90,029	(9.2)

이러한 중점관리 “M”을 클릭하면 물리치료횟수 청구현황 화면으로 연동되어 물리치료 청구횟수 및 인정비율 등을 확인하도록 되어있으나, 심사직원 1명이 처리해야 하는 심사 물량이 많고 이에 따라 확인해야 하는 요양기관이 많으며 조회 화면 로딩에 시간이 소요되거나 화면이 꺼지는 등의 문제로 건건이 확인하는데 한계가 있을 것으로 판단된다.

【그림 2】 청구서 처리 화면의 중점관리 “M” 표시

접수일	접수번호	도시과목	현지 조사 대상	계류일 심사목	건요년월 보험자	연구 중심 주제	심사방법	위탁 선별	관리 관리CI	접수업종	분배업종
분배일	오염기호	오염기관명	분배 상사	심사목	보험자	중심 주제	전문자료	선별	관리CI	접수회차	분배회차
2022-11-02		일반의		2	2022-10-01	일반	AA		M		
2022-11-04				S	보험	M		SC3	1.176	1,868	481
2022-11-01		가정의학과		3	2022-10-01	일반	CC		3	I	
2022-11-02			Y	S	보험	M		SC3	0.936	2,330	927
2022-11-01		외과		3	2022-10-01	일반	CC				
2022-11-02			Y	S	급여	M		SC3	0.884	172	172
2022-11-01		가정의학과		3	2022-10-01	일반	CC		2		
2022-11-02			Y	S	급여	M		SC3	0.971	170	49
2022-11-01		일반의		3	2022-10-01	일반	CC		8		
2022-11-02			Y	S	급여	M		SC3	0.917	639	385
2022-11-02		가정의학과		2	2022-10-01	일반	CC		39		
2022-11-03			Y	S	보험	M		SC3	1.093	1,798	686
2022-11-02		재활의학과		2	2022-10-01	일반	CC				
2022-11-03				S	급여	M		SC3	0.574	71	71
2022-11-01		정형외과		3	2022-10-01	일반	CC		11	M	
2022-11-02			Y	S	보험	M		SC3	0.869	1,132	207
2022-10-31		내과		4	2022-10-01	일반	AA		110	W	
2022-11-01			Y	S	보험			SC3	1.174	713	50

그리고 심사직원은 물리치료 인정비용 산출을 위해 물리치료횟수 청구 현황 화면과 한방물리요법 청구현황 조회 화면을 활용하고 있다.

물리치료횟수 청구현황 화면은 접수번호별 청구현황과 인정가능 횟수가 산출·계산되어 인정비율이 자동 계산되어 보여 지고 있으나, 요양기관의 청구입력 오류가 다발생하는 등의 사유로 인정가능 횟수 산출 시 물리치료사 공휴일 현황이 합산되지 않아 심사직원이 건건이 조회하여 수기로 계산하고 있다.

【그림 3】 물리치료횟수 청구현황 공휴일 조회 화면

[illegible]

또한 해당 화면에서 입원 청구횟수가 합산되지 않아 물리치료 인정비율을 수기로 계산하여야 하여 물리치료 인정비율 착오계산 등의 오류가 발생할 수 있는 위험이 항시 존재하고 있다.

【그림 5】 한방물리요법 청구현황 조회 화면

[illegible]

대부분 피감부서에서 상기 두 화면에서 표기되는 물리치료 인정비율을 그대로 적용하고 있음을 설문조사 및 의견수렴 과정에서 확인되었다.

물리치료횟수 청구현황

[illegible]

한방물리요법 청구현황 조회

심사직원은 월 인정 가능 횟수와 청구 횟수를 비교하여 물리치료 인정 비율 심사가 필요한 경우, 【그림 7】과 같이 일정비율(%)을 수기로 입력하여 심사 조정처리하고 있다.

그러나 【그림 8】과 같이 물리치료횟수 청구현황 화면에서 합계란의 물리치료 인정비율은 소수점 둘째자리까지 표시되어 있으나, 접수번호별 물리치료 인정비율은 소수점 첫째자리까지 표시되어 있었으며, 한방물리요법 청구현황 조회 화면의 인정비율은 소수점 둘째자리까지 표시되어 있었다.

특히 물리치료횟수 청구현황 조회 화면과 물리치료 정산대상 조회 화면에서 모두 실제 적용한 물리치료 인정비율 값을 표시하고 있으나, 물리치료횟수 청구현황 조회 화면에서는 실제 적용한 물리치료 인정비율의 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리로 표시하고 있었다.

물리치료횟수 청구 현황

PPT_ID : RV90370868	요양기호 :	출력자 :
진료년월 : 2021-10	요양기관명 :	출력일 :
청구단위 : 전체	보험자 : 전체	배치지 :
	전화번호 :	

▶ 청구횟수

진료년월 발급구분	접수번호	접수일자	입/퇴	청구형태	보험자	심사 방법	진료분류	물리치료 정선비율	전문재활치료 청구회수(전문가검정률)									
									전문가 검정률	전문가 검정률	보행물	전신물	중추신경계 방음재활치료	척추관절 치료	목수술후 치료	연하장애 재활치료	언어장애 재활치료	언어장애 재활치료
2021.10-0		외래	전자문서	보통	CC			93.8	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10-0		외래	전자문서	급여	CC				63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
								63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								합계	832	832	0	0	0	0	0	0	0	0
									832	832	0	0	0	0	0	0	0	0

한방물리요법 청구현황 조회

▶ 한방물리요법청구현황조회

외면처리

• 요양기호

• 진료년월 2022-02 ☐ 연월 ☐ 주 ☐ 2주 ☐ 3주 ☐ 4주 ☐ 5주 ☐ 6주 • 사용 ☐ • 접수일자 2022-09-21 - 2022-10-20
 조회

▶ 접수일자별 요양기관 물리요법 현황 주4번까지 1인당 1일 진료가능인원 + 30명 주4번 한방 물리요법 청구현황은 심사 시 참고자료이므로 요양기관이 인적사항 및 진료내역등을 파악하여 심사 작성바람.

접수일자	요양기호	요양기관명	전화번호	의사수	N자등 여부	물리(참고지)		전신요법		민정요법		총청구 회수(B)	인정비율 (A)/(B)*100		
						병원 근로일수	민정 인정회수	전체 전신요법	토요일공휴일 전신요법(MT050)	전체 민정요법	차등 민정요법(MT050)				
2022-09-02				1	N	22	660	20	20	0	600	600	0	607	98.04

물리치료 정산대상 조회

물리치료정산대상 조회

1학시제 > 심사차인

• 심사부 전체 • 심사조 전체 • 진료년월 2021-09 - 2022-02
 조회

• 요양기호

요양기호	요양기관명	진료년월	접수일자	접수번호	청구형태	보험자	전료형태	진료구분	성질명	물리치료 청구횟수		인정비율	정선비율
										내향 포함	내향 제외		
		2021-09	2021-10-01		전자문서	건강보험	외과	외래	1	736	736	95.5	0
		2021-09	2021-10-01		전자문서	의료급여	외과	외래	1	71	71	95.5	0
		2021-09	2021-10-30		전자문서	건강보험	외과	외래	1	769	769	93.75	0.8299
		2021-10	2021-10-30		전자문서	의료급여	외과	외래	1	63	63	0	0.8293

물리치료횟수 청구 현황, 한방물리요법 청구현황 조회, 물리치료 정산대상 조회 화면(이하 “물리치료 인정비율 조회 가능화면”)의 소수점 자리 표시 뿐만 아니라, 소수점 자리 계산 방법도 서로 다르게 적용하고 있었다.

물리치료횟수 청구현황 화면에서 조회되는 합계란의 인정비율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표기하고 있었고, 한방물리요법 청구현황 조회 화면에서는 소수점 셋째자리에서 절사하여 소수점 둘째자리까지 표기하는 등 심사 시 참고하는 화면도 의과·한방에 따라 산출방법이 상이함을 확인하였다.

이처럼 물리치료 인정비율 조회 가능화면에 따라 표기방법 및 산출방법이 각각 상이하여, 물리치료 인정비율 산출·적용방법에 대한 관련 기준 등을 검토하였다.

먼저 재할 및 물리치료료 횟수 과다산정 시 초과율 적용 심사조정방법에 대한 기준을 검토한 중심조(1998.4.1.)에서는 소수점 둘째자리에서 절사하여 소수점 첫째자리까지 산출하도록 명시하고 있다.

☞ **참고자료: 【중심조 1998.4.1.】**

재할 및 물리치료료 횟수 과다산정시 초과율 적용 심사조정방법에 대하여

가. 부의배경

- 1998. 3. 9. 지부심사과장회의 안건으로 부산지부에서 지의
- 재할 및 물리치료료 횟수 과다청구시 초과율 심사조정방법 재검토 요청

나. ~ 마. (생 략)

바. 결정사항

- 1) 재할 및 물리치료료 횟수 과다산정시 초과비율 산출방법은 [재할 및 물리치료 실시 시한 인정등 기준]중 처분기준에 의한 부담비율 산출방법과 동일하게 **소수점 둘째 자리에서 절사하여 심사 조정**키로 함.

예) 8.25% -> 8.2%, 8.75% -> 8.7%

- 2) (생 략)

그러나 피감부서의 업무매뉴얼은 물리치료 인정비율 산출·적용방법에 따른 기준이 마련되어 있지 않았고, ◆◆실의 요양기관 현지조사 업무매뉴얼에는 소수점 넷째자리(백분율 기준 소수점 둘째자리)에서 올림하여 소수점 첫째자리까지 산출·적용하도록 명시하고 있었다.

☞ **참고자료: 【◆◆실 요양기관 현지조사 업무매뉴얼】**

① 물리치료 비율조정 구하는 방법

1차원심 비율조정 없는 경우	부당 진료월	물리치료 청구횟수	인정가능 물리치료횟수 (현지조사 후)	계산식 (인정비율)	인정 비율	인정 백분율	조정 비율
	2012.7.	1,338	900	900/1,338=0.67264.. (소수점 넷째 자리에서 올림)	0.673	67.3%	(1-인정비율) = 0.327
※ 비율조정 탭에서 ‘인정내역’ 상태로 인정비율 입력							

1차원심 비율조정 있는 경우	구분	계산식	2012.7월
	원심	물리치료 청구횟수	1,338
		물리치료 인정가능 횟수	1,110
		1차 심사 인정비율(%): 1,110/1,338*100	83%
		1차 심사 조정비율(%): 100-83	17%
	현지 조사 확인	물리치료청구횟수	1,338
		물리치료 인정가능 횟수	900
		현지조사 후 인정비율(%): 900/1,338*100 (소수점 넷째자리 올림)	67.3%
		현지조사 확인 후 조정비율(%):100-67.3	32.7%
	정산	정산인정비율(%):	84.3%
		현지조사 후 인정비율+1차심사 조정비율	
		정산조정비율(%): 100-정산인정비율	15.7%
	※ 비율조정 탭에서 ‘조정내역’ 상태 정산조정비율 입력		

이렇듯 【표 4】와 같이 물리치료 인정비율 조회 가능화면 및 관련 기준·업무매뉴얼마다 물리치료 인정비율을 각각 상이하게 명시·계산하고 있어 심사 시 혼란을 야기할 수 있다고 판단된다.

【표 4】 물리치료 인정비율 조회 가능화면 및 기준 산출방법 분석

구분		현황
적용방법	소수점 첫째자리	◆◆실 업무매뉴얼, 중심조(98.4.1.)
	소수점 둘째자리	물리치료횟수 청구현황, 한방물리요법 청구현황 조회
계산방법	올림	◆◆실 업무매뉴얼
	반올림	물리치료횟수 청구현황
	절사	중심조(98.4.1.), 한방물리요법 청구현황 조회

* 수감부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 피감부서별 물리치료 인정비율 산출·적용방법을 검토한 결과, 【표 5】와 같이 부서마다 적용하는 소수점 자릿수도 상이하였으며, 산출방법 또한 다를 것을 확인하였다. 특히 일부 피감부서에서는 1차 심사와 사후 심사의 산출방법도 달리 운영하고 있었다.

【표 5】 피감부서별 물리치료 인정비율 적용·산출방법 분석

구분		운영현황
적용방법 (의과/한방기준)	소수점 첫째자리	5개 부서 (○○, ♥♥, ♣♣, ♠♠, ▷▷)
	소수점 둘째자리	5개 부서 (◎◎, ◇◇, □□, △△, ◁◁)
계산방법	올림	4개 부서 (○○, ♥♥, ♠♠, ▷▷)
	반올림	4개 부서 (◇◇, □□, △△, ♣♣)
	절사	2개 부서 (◎◎, ◁◁)
1차 심사, 사후정산	동일 방법 적용	8개 부서 (○○, ◎◎, ◇◇, □□, △△, ♥♥, ▷▷)
	별도 방법 적용	2개 부서 (♣♣, ♠♠)

* 수감부서 제출자료 재구성

물리치료 인정비율 산출·적용방법뿐만 아니라, 물리치료 인정비율 변동이 발생하는 경우에 따른 적용 및 관리 기준도 부서별로 달리 운영하고 있었다.

물리치료 인정비율 변동이 발생하는 경우는 주단위·월단위 청구 기관과 같이 청구방법과 청구시점이 모두 차이나는 경우와 건강보험과 의료급여, 입원과 외래 등의 청구방법의 차이, 지연 청구하거나 추가·보완청구 또는 물리치료사 지연신고 등의 청구시점의 차이로 구분할 수 있으며,

청구방법 및 청구시점 차이에 대한 운영·관리 현황은 【표 6】과 같으며, 상세 내용은 다음과 같다.

【표 6】 피감부서별 물리치료 인정비율 합산심사 운영현황

구분		운영현황		
		합산심사 시행		합산심사 미시행
청구방법, 청구시점	주단위-월단위 청구	4개 부서 (□□, △△, ♠♠, ◁◁)		6개 부서 (○○, ◎◎, ◇◇, ♥♥, ♣♣, ▷▷)
청구방법	보험-급여	전 부서		-
	입원-외래			
	정액청구 기관	3개 부서 (◇◇, ♥♥, ♠♠)		7개 부서 (○○, ◎◎, □□, △△, ♣♣, ◁◁, ▷▷)
청구시점	지연 청구 및 추가·보완 청구 등	7개 부서 (○○, ◇◇, △△, ♣♣, ♠♠, ◁◁, ▷▷)		3개 부서 (◎◎, □□, ♥♥)
	물리치료사 지연신고	주기적 시행	2개 부서 (♣♣, ♠♠)	-
		수시로 시행	8개 부서 (○○, ◎◎, ◇◇, □□, △△, ♥♥, ◁◁, ▷▷)	

* 수감부서 제출자료 재구성

첫째, 청구방법과 청구시점이 모두 차이나는 주단위-월단위 청구 기관의 경우는 【예시1】과 같이 주단위 청구 건을 심사 완료한 후 월단위 청구로 해당 진료단위의 물리치료 인정비율 변동이 발생한 경우로, 해당 진료단위 전체 청구 건의 합산심사 여부도 피감부서마다 상이하였다. 일부 부서에서는 의과의 경우 합산심사를 시행하고, 한방은 합산심사를 시행하지 않는 등 부서 내에서도 일관된 기준이 없음을 확인하였다.

【 예시1 】					
구분	접수 날짜	인정가능 횟수	물리치료 청구횟수	물리치료 인정비율	확인 내용
주단위 청구	1주차	9/5	120	115	100
	2주차	9/12	210	207	100
	3주차	9/19	210	255	82.35
	4주차	9/26	210	225	93.33
	5주차	10/3	150	158	94.93
월단위 청구	10/10	-	40	-	
전체 합산		900	1,000	90.00	-

둘째, 청구방법 차이에 따른 합산 심사 여부를 피감부서별로 확인한 결과, 건강보험-의료급여, 입원-외래 청구방법에 차이에 따른 심사는 전 부서에서 합산하여 심사 적용하고 있었다.

다만 【예시2】와 같은 정액 청구기관의 행위별 수가 청구 시 물리치료 인정비율은 상이하게 적용 중임을 확인하였다. 입원일당 정액으로 적용하는 경우 일부 물리치료료가 포함되어 있어 물리치료 인정비율에 따라 심사 조정할 수 없다. 그러나 정액을 주로 청구하는 기관에서 행위별 청구가 일부 들어온 경우, 정액수가에 청구한 물리치료 횟수와 합산하여 인정비율을 산출·적용하는지에 대한 의견이 분분하였다.

【 예시2 】				
구분	접수날짜	인정가능 횟수	물리치료 청구횟수	물리치료 인정비율
정액 청구	5/12	800	900	미적용
행위별 청구	5/12		100	① 정액청구 횟수와 합산하여 행위별 청구 조정 ② 인정비율 미조정
전체 합산		800	1,000	80.00

셋째, 【예시3】과 같이 지연 청구나 추가청구·보완청구 등과 같이 청구시점이 다른 경우, 심사 결정 완료된 청구 건의 재심 여부뿐만 아니라 접수시점이 다른 청구 건의 인정비율 적용도 상이하였으며, 일부 부서에서는 의과와 한방을 달리 적용하기도 하였다.

【 예시3 】					
구분	접수 날짜	인정가능 횟수	물리치료 청구횟수	물리치료 인정비율	확인 내용
심결 완료	접수번호A	1/1	982	1,544	97.15
	접수번호B	1/1	112		97.15
	접수번호C	1/1	370		97.15
	접수번호D	1/1	80		97.15
지연 청구	접수번호E	9/11	56	-	-
전체 합산		1,500	1,600	93.75	-

마지막으로 【예시4】와 같이 물리치료사 지연신고에 따른 물리치료 인정비율 변동으로 기존 심사 완료된 건에 대해 물리치료사 지연신고를 반영한 합산심사를 진행하는지 여부를 확인하였다.

【 예시4 】

구분	인정가능 횟수	물리치료 청구횟수	물리치료 인정비율	확인 내용
심결 완료	500	600	83.33	① 물리치료사 지연신고 반영하여 재심 조정
물리치료사 지연신고로 인정가능 횟수 440으로 조정				② 물리치료사 지연신고 미반영
전체 합산	440	600	73.33	

심사직원은 요양기관의 인력현황 및 진료내역을 파악하여 물리치료 인정 비율을 산출 및 심사적용을 하여야 하며, 요양기관에서 인력 변경현황을 지연하여 신고하는 경우에 대해 기 지급된 요양급여비용의 과다지급 여부를 확인하여야 한다.

그러나 인력 지연신고에 대한 관리를 수시로 진행하는 부서가 대부분이었고, 일부 부서에서만 주기적으로 관리하고 있음을 설문조사 및 의견수렴 과정에서 확인되어 수시 관리 시 누락 될 수 있는 위험은 지속 되고 있음을 확인할 수 있었다.

다. 심사 사후관리 업무

요양기관은 물리치료사가 공휴일에 근무하거나 한의사가 토요일·공휴일에 근무한 경우에 특정내역 코드 MT025 및 MT050을 입력하여 근무일자와 근무자 수를 입력하여야 하며, 심사직원은 이를 반영하여 물리치료 인정비율 산출하여야 한다.

 참고자료: 【요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령】

구분코드	특정내역	작성요령 및 기재형식
MT025	물리치료사 공휴일근무 현황	◆ 1개월 또는 1주일동안 물리치료사가 공휴일 근무한 경우 공휴일 근무일자와 근무자수를 기재(접수번호별 첫 번째 명일련에만 기재) ※ 공휴일 근무일수가 2일 이상인 경우 각각 기재 ※ 단, 시간제, 격일제 근무자는 주3일 이상 이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 산정 ◆ 기재형식: ccyyymmdd/9(1).V9(1) ◆ (예시) (생 략) ◆ 적용일: 2008.10.27.부터
MT050	한의사 토요일·공휴일 근무현황	◆ 한의원에서 토요일·공휴일의 진찰료에 대하여 차등수가를 제외 (N차등)하는 경우 1개월 또는 1주일동안 한의사가 근무한 토요일·공휴일의 근무일자와 한의사수를 기재(접수번호별 첫 번째 명일련에만 기재) ※ 토요일·공휴일 근무일수가 2일 이상인 경우 각각 기재 ※ 단, 시간제, 격일제 근무자는 주3일 이상이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 산정 ◆ 기재형식: ccyyymmdd/9(1).V9(1) ◆ 적용일: 2016.7.1. 진료분부터

그러나 의견수렴 과정에서 요양기관에서 MT025 및 MT050 기재를 누락하는 경우가 많다는 의견이 제시되어, 감사 대상기간의 특정내역 기재 현황 및 특정내역 기재 누락 시 처리방법 등에 대해 검토하였다.

그 결과 【표 7】과 같이 진료일자가 공휴일(한방 청구 건은 토요일·공휴일)이면서 물리치료 청구가 들어온 명세서 중에서 MT025 및 MT050 기재하여 청구한 경우는 약 6만 건으로 8.8%에 불과하였다.

【표 7】공휴일 근무 관련 특정내역 기재 현황

(단위: 건, %)						
구분	전체		의과		한방	
공휴일 청구 건	6,910,511	(100.0)	1,103,351	(100.0)	5,807,160	(100.0)
특정내역 기재	610,557	(8.8)	84,739	(7.7)	525,818	(9.1)

이에 심사직원은 심사록²⁾에서 조회하거나 갑자기 조정비율이 발생하는 요양기관이나 명절이나 여름휴가 기간 등을 고려하여 요양기관을 임의로 선별하여 유선으로 확인하거나 청구내역에서 물리치료 청구일자를 확인하는 등의 방법으로 개별 확인하는 등 심사 효율이 저하되고 있음에도 별도 확인 작업을 거쳐 심사하고 있었다.

이와 관련하여 MT025 및 MT050 기재 누락에도 불구하고 토요일·공휴일 근무현황에 대해 심사직원이 개별 확인하여 심사 적용하는지 여부와 확인 방법에 대해 설문조사 결과, 【표 8】과 같이 상이하게 운영 중이었으며 일부 피감부서에서는 부서에 따라 다르게 운영하기도 하였다.

【표 8】피감부서별 공휴일 근무현황 확인 여부

구분	관리현황
개별 확인	7개 부서(○○, ◎◎, ◇◇, □□, △△, ♥♥(2부), ◁▷)
미확인	4개 부서(♡♡(1부), ☹☹, ♫♫, ▷▷)

* 수감부서 제출자료 재구성

또한 피감부서에서 물리치료 인정비율 심사 누락 방지를 위한 사후관리 방안에 대해 의견수렴 및 설문조사를 진행한 결과, 대부분 피감부서에서 사후관리 시 물리치료 정산대상 조회 화면을 이용하고 있었다.

물리치료 정산대상 조회 화면은 물리치료 인정비율 조정이 1건 이상 발생한 진료년월에 해당하는 모든 접수번호가 조회되어 물리치료 비율적용이 서로 상이하거나 추가조정이 필요한 경우를 확인하도록 조회하는 화면으로 접수번호 단위별 일부 누락된 경우 조회되나, 비율 조정된 접수번호가 없는 경우는 조회되지 않는다.

그러나 일부 부서에서는 해당 화면을 물리치료 인정비율 심사 사후관리 화면으로 인지하고 있었다.

☞ **참고자료: 【HIRA+ 화면심사 사용자 매뉴얼】**

2-7-7. 물리치료 정산 대상 조회(JSE082)

물리치료의 비율적용이 상이하거나 미적용 되어 심사완료된 명세서 추가조정이 필요한 경우 조회하는 화면

○ 작업요령

① 심사메인 메뉴에서 「심사처리」 → 「심사정보」 → 「물리치료 정산 대상 조회」를 선택한다.

② 심사부별로 조회하고 접수일자, 진료년월 또는 요양기관 등 조건을 지정할 수 있다.

③ 심사마감 건 중 인정비율이 존재하는 접수번호가 조회되며, 진료년월/심사년월/접수일자/접수번호의 조회조건 중 비율조정이 있는 접수번호가 존재하는 경우 그 접수번호와 동일한 진료년월의 접수번호가 모두 조회된다.

④ 엑셀저장을 누르면 해당 내역을 저장할 수 있다.

이러한 물리치료 정산대상 화면을 이용한 접수번호 단위별 심사 사후관리는 【표 9】와 같이 주기적으로 관리하는 부서와 수시로 관리하는 부서로 구분되며, 주기적으로 관리하는 부서들도 그 간격에 대해서는 상이하게 운영 중임을 확인하였다.

2) 요양기관의 청구현황과 분기 주요지표 및 심사 상 문제점 등을 입력·조회

- 21 -

- 22 -

【표 9】 피감부서별 사후관리 현황

구분	관리현황	
주기적으로 사후 관리	매월	1개 부서(<△>)
	분기	2개 부서(○○, ▷▷)
	반기	3개 부서(△△, ♀♀, ♀♂)
수시로 사후 관리	4개 부서(◎◎, ◇◇, □□, ♥♥)	

* 수감부서 제출자료 재구성

물리치료 정산대상 화면을 이용한 사후정산 외에 피감부서에서 별도로 시행하고 있는 사후 정산에 대해 설문조사한 결과, 피감부서에서 표준화된 사후 관리 체계를 운영하고 있지 않았다.

이와 관련하여 일부 부서에서는 물리치료 정산대상 화면 개선 등 일괄적인 사후관리 체계 마련에 대한 의견을 제시하는 등 물리치료 정산대상 화면에 대한 이해를 높이고 피감부서별 상이한 사후관리 방법 및 주기 등을 표준화할 필요성이 확인되었다.

물리치료 인정비율 심사 관련 문제점 및 개선 필요사항을 전반적으로 검토한 결과, 심사누락의 원인으로 크게 피감부서별로 상이한 심사 운영방법, 시스템 미흡, 사후관리체계 미비로 확인되었다.

물리치료 인정비율은 물리치료 청구와 물리치료사·한의사 인력현황 등에 따라 산출되는데 피감부서별로 상이한 산출방법·심사·사후관리를 운영하고 있어 본·지원별 표준화된 관리체계를 마련할 필요가 있으나, 기 지급된 요양급여비용의 정산 문제 및 청구 시점에 따른 인정비율 변동 문제가 지속적으로 발생하는 등 어려움이 있다.

또한 물리치료 인정비율 심사 시스템의 제한적 전산화로 일부 청구횟수가 미포함되거나 중점관리 표시 미흡 등 물리치료 인정비율 심사 관련 시스템이 미흡한 부분도 발견되었으나, 이는 피감부서별 표준화된 심사방법 마련과 병행하여 검토되어야 할 것으로 판단된다.

그리고 청구 시점의 차이, 지연 신고 등에 따라 물리치료 인정비율 사후 관리가 필요함에도 불구하고 별도의 사후관리 체계가 마련되어 있지 않았으며, 물리치료 정산대상 조회 화면을 통한 사후 관리는 일부 접수번호 단위별 심사누락만 조회되어 청구 단위 심사누락 등 전체 현황을 관리하기에는 한계가 있다.

다만, 물리치료 인정비율은 청구·인력신고 시점에 따라 변동이 발생할 수 있고 이에 따라 원심, 재심 등의 연계 심사 과정에 반영하여야 하여 앞서 제기된 문제들에 대해 선행 검토가 필요한 것을 우선으로 하여 심사 일관성을 제고할 필요가 있다.

이에 피감부서별 상이한 심사방법에 대한 표준안을 마련하고 물리치료 인정비율 심사와 관련된 시스템 개선에 대한 검토가 필요하며, 이와 관련 사후관리 방안과 연계하여 논의할 필요가 있다.

따라서 피감부서는 물리치료 인정비율 관련 요양급여비용을 정산(환수) 처리하고, ●●실 및 ▲▲실은 전 지원과 협력하여 물리치료 인정비율 심사가 효율적으로 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

관계부서는

향후 감사결과를 토대로 물리치료 인정비율 심사 누락 방지를 위해 물리치료 인정비율 심사 표준안 마련 및 시스템 개선 방안 마련 등 노력하겠다는 의견을 제시하였음

조치할 사항

① 관련 부서장은

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에 따른 물리치료 인정비율 적용 및 요양급여비용 조정을 누락한 요양기관에 대해 62,004,811원(추정)의 요양급여비용을 정산하시기 바라며, 물리치료 인정비율 심사 표준안 마련 및 시스템 개선에 적극 참여하여 주시기 바랍니다. (시정)

② 업무상임이사는

전 지원과 협업하여 피감부서별 상이하게 적용 중인 물리치료 인정비율 산출방법 및 사후관리 등 심사 운영방안에 대한 표준안을 마련하여

주시고 이와 연계하여 물리치료 인정비율 관련 현황이 정확히 조회되고, 원활히 심사에 적용할 수 있도록 시스템 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.

(권고)